

医药生物

美股医药 2021 中报会议纪要系列：赛诺菲（SNY.US）

2021年7月29日，赛诺菲公布2021年中报。2021年初至今，公司实现收入173.35亿欧元，同比增长0.9%；调整后净利润为37.48亿欧元，同比增长6.4%，调整后净利率21.6%，对应EPS3.00欧元。2021Q2单季度收入87.44亿欧元，同比增长6.5%；调整后净利润为17.31，同比增长8.1%，对应EPS为1.38欧元。中国区2021H1总营收13.8亿欧元，同比增长6.3%，未来业绩或将受到胰岛素带量采购影响。文章内容来自赛诺菲2021二季度业绩会。

三大板块业务增长稳定，制药业务收入占比较重。制药业务板块H1销售额为132亿欧元（+1.4%），其中免疫炎症销售额为34.40亿欧元（+27.9%），Dupixent（Dupilumab, IL-4R）强势放量（+51.4%）占据总营收13.2%，仍是赛诺菲目前最重磅明星产品。抗肿瘤药物销售额4.47亿欧元（+25.6%），胰岛素药物销售额为23.21亿欧元（-0.1%），疫苗板块H1总销售额为19.4亿欧元（+5.5%），Q2单季度销售额迈入了10亿欧元大关（+16.2%），脑膜炎疫苗需求拉升；消费者健康板块销售额22.02亿欧元（+1.2%），总体增长平稳。

公司研发管线储备丰富，涉及疾病领域广泛。公司现有研发管线164条，包含免疫，肿瘤，心血管，罕见病等多个领域。2021H1，FDA批准了用于Dupixent（Dupilumab, IL-4R）的200毫克单剂量预装笔，授予rilzabrutinib快速通道，用于其在寻常型天疱疮中的开发。欧盟委员会(CE)批准Libtayo（cemiplimab-rwlc, PD-1）作为两种晚期癌症（非小细胞肺癌，局部晚期或转移性基底细胞癌）的单一疗法，Sarclisa（isatuximab-irfc, CD38）治疗复发性多发性骨髓瘤的适应症，Aubagio用于治疗10-17岁复发缓解型多发性硬化症(RRMS)的儿科患者。临床一期四项进展，临床二期八项进展，临床三期四项进展。新冠肺炎重组蛋白疫苗2021Q2临床三期开展，mRNA疫苗2021Q1临床1/2期开展。

风险提示：研发管线进展阻滞；仿制药侵占市场；新冠肺炎疫情复发。

行业走势



作者

分析师 张金洋

执业证书编号：S0680519010001

邮箱：zhangjy@gszq.com

分析师 胡儒碧

执业证书编号：S0680519010003

邮箱：huruobi@gszq.com

相关研究

- 1、《医药生物：创新药周报：聚焦特效治疗药，应对新冠“流感化”》2021-08-08
- 2、《医药生物：十三张图表，看清全球疫情与新冠疫苗最新进展》2021-08-08
- 3、《医药生物：创新药周报：罗氏、辉瑞中报业绩出彩，新冠相关产品乘势而上》2021-08-02

内容目录

三大板块业务增长稳定，度普利尤单抗一枝独秀	3
业绩概览	3
业绩拆分	4
制药业务	5
疫苗业务	9
消费者保健业务	9
研发进展	12
Q&A	17
风险提示	19

图表目录

图表 1: 赛诺菲上半年业绩概括	3
图表 2: 2016-2021 年 H1 收入拆分 (%)	4
图表 3: 2021H1 各大模块收入及增速	4
图表 4: 赛诺菲历史收入及增速情况 (亿欧元)	4
图表 5: 赛诺菲历史净利润及增速情况 (亿欧元)	4
图表 6: 不同地区收入比例	5
图表 7: 2021H1 不同地区销售收入增速	5
图表 8: 药品板块收入拆分	6
图表 9: 药品各板块收入增速	6
图表 10: 2021H1 罕见病药物收入及增速	6
图表 11: 多发性硬化症/免疫炎症药物销售额 (亿欧元)	7
图表 12: 药品销售收入分类 (%)	9
图表 13: 2021H1 消费保健 (亿欧元)	10
图表 14: 公司药品收入及增值 (亿欧元)	10
图表 15: 临床阶段管线占比	12
图表 16: 不同疾病领域管线占比	12
图表 17: 公司重要研发项目进度安排及实际完成情况	14
图表 18: 新冠疫苗研发进展	15
图表 19: SAR'245: 潜在的 BIC IL-2	16
图表 20: 预计 2021 年下半年将实现关键的制药研发里程碑	16
图表 21: 预期管线项目完成提交时间表	17

三大板块业务增长稳定，度普利尤单抗一枝独秀

交流时间：2021 年 7 月 29 日

交流领导：赛诺菲公司高层

注：文章内容来自赛诺菲 2021Q2 Earnings Conference Call 公开电话会议。

2021H1 公司实现收入 173.35 亿欧元，同比增长 0.9%；调整后净利润为 37.48 亿欧元，同比增长 6.4%，调整后净利率 21.6%，对应 EPS 3.00 欧元。2021Q2 单季度收入 87.44 亿欧元，同比增长 6.5%；调整后净利润为 17.31 亿欧元，同比增长 8.1%，对应 EPS 为 1.38 欧元。制药板块，上半年 Dupixent (Dupliumab, IL-4R) 强势放量 (+51.4%)，占据总营收 13.2%，仍是赛诺菲目前最重磅明星产品。疫苗板块，Q2 单季度销售额迈入了 10 亿欧元大关 (+16.2%)，脑膜炎疫苗需求拉升。中国区 2021H1 总营收 13.8 亿欧元，同比增长 6.3%，未来业绩或将受到胰岛素带量采购影响。

业绩概览

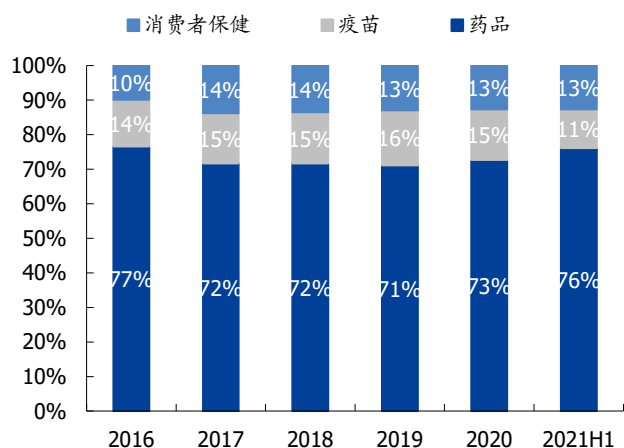
图表 1：赛诺菲上半年业绩概括

	2021Q2	增速	2021H1	增速	占收入比
销售收入 (亿欧元)	87.44	6.5%	173.35	0.9%	100%
成本 (亿欧元)	28.57	6.7%	55.41	0.0%	32%
销售毛利 (亿欧元)	58.87	6.5%	117.94	1.3%	68%
销售费用 (亿欧元)	23.36	3.1%	45.30	-1.7%	26%
研发费用 (亿欧元)	13.97	3.3%	26.63	-1.1%	15%
调整后净利润 (亿欧元)	17.31	8.1%	37.48	6.4%	22%
调整后 EPS (欧元)	1.38	7.8%	3.00	6.8%	

资料来源：赛诺菲公司公告，国盛证券研究所

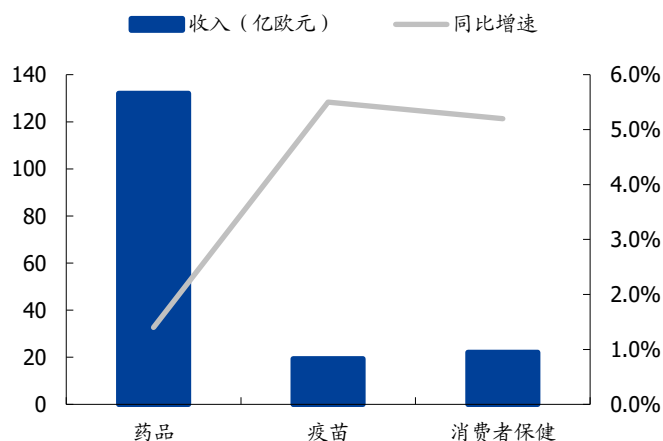
- **2021H1**，公司合计收入 **173.35 亿欧元**，按照恒定实值汇率算 (CER)，同比增长 7.2%，若以欧元计算则同比上升 0.9%。EPS 为 3.00 欧元，同比增长 6.8%。
- **2021Q2**，公司合计收入 **87.44 亿欧元**，按照恒定实值汇率算 (CER)，同比增长 12.4%。若以欧元计算则同比上升 6.5%。EPS 为 1.38 欧元，同比增长 7.8%。

图表 2: 2016-2021 年 H1 收入拆分 (%)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

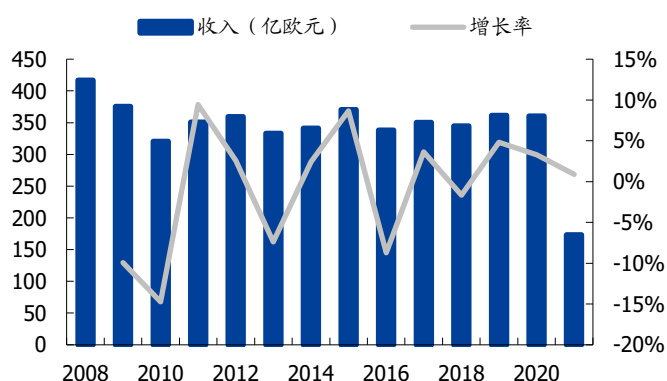
图表 3: 2021H1 各大模块收入及增速



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

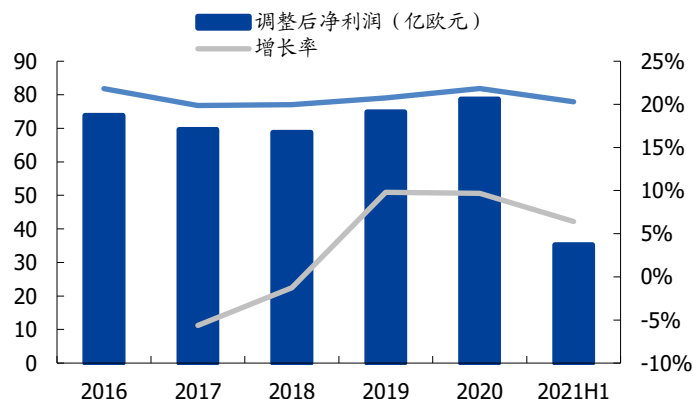
➤ **2021 年业绩指引: 全年收入段处于低位个位数增长, 净利润增速大于收入增速。**

图表 4: 赛诺菲历史收入及增速情况 (亿欧元)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

图表 5: 赛诺菲历史净利润及增速情况 (亿欧元)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

业绩拆分

按照销售地区

- 分为美国, 欧洲以及其他地区三大地区。
- 截止到目前, 2015 年以后三大地区的收入占比基本稳定, 主要来源于美国 (36.6%) 和欧洲 (25.7%), 中国 (7.5%) 和日本 (4.5%) 收入占比较低。

图表 6: 不同地区收入比例

	美国	新兴市场	欧洲	其他地区
2015	36%	32%	22%	10%
2016	37%	28%	26%	9%
2017	34%	29%	27%	10%
2018	33%	29%	27%	10%
2019	35%	30%	25%	10%
2020	37%		25%	37%
2021H1	35%		26%	39%

资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

- **2021 年上半年, 美国地区收入增速同比增长 13%, 日本和俄罗斯地区收入出现负增长。**

图表 7: 2021H1 不同地区销售收入增速

	2021Q2 (亿欧元)	占比	同比增长	2021H1 (亿欧元)	占比	同比增长
美国	31.95	36.54%	20.40%	60.88	35.12%	13.30%
欧洲	22.44	25.66%	14.40%	44.72	25.80%	3.40%
其他国家	33.05	37.80%	4.20%	67.75	39.08%	4.30%
中国	6.54	7.48%	4.00%	13.80	7.96%	6.30%
日本	3.96	4.53%	4.80%	8.30	4.79%	-2.60%
巴西	1.95	2.23%	10.50%	4.53	2.61%	17.40%
俄罗斯	1.49	1.70%	-3.50%	3.00	1.73%	-4.90%
合计	87.44	100.00%	12.40%	173.35	100.00%	7.20%

资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

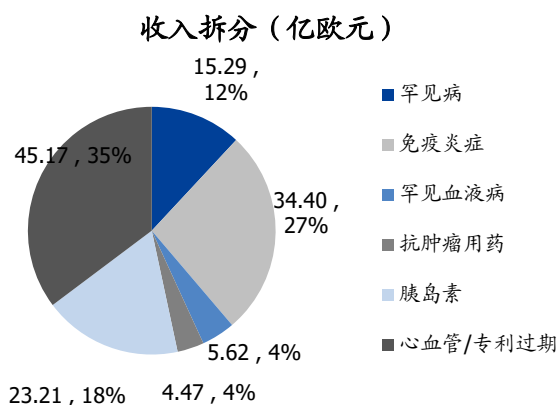
按业务板块

分为三大板块: 制药业务、疫苗业务和消费者保健业务。

制药业务

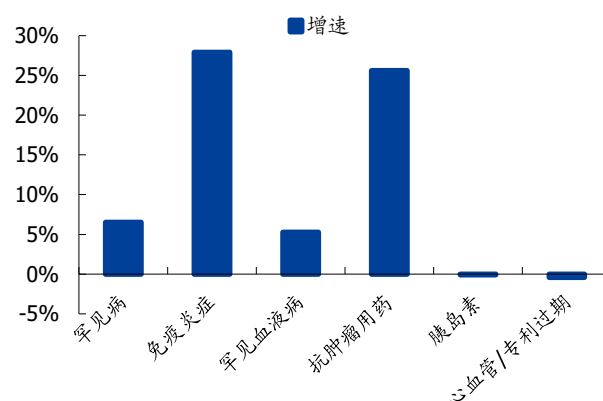
2021 年上半年制药业务销售额 131.96 亿欧元, 在 CER 下同比增长 7.7%。2021 年第二季度药品销售额 66.33 亿欧元, 在 CER 下同比增长 11.9%, 得益于 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 强劲表现, 维持的特殊护理产品组合增长 22.0%, 而普通药物销售额增长 4.2%, 也由于 **COVID-19** 的影响导致 **2020 年第二季度的数据表现低迷。**

图表 8: 药品板块收入拆分



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

图表 9: 药品各板块收入增速

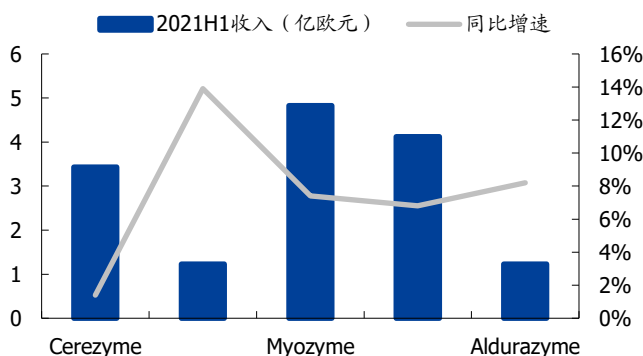


资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

罕见病

- 罕见病的上半年销售额增长了 **6.5% (CER)**, Cerezyme (重组葡萄糖脑苷脂酶, 葡萄糖脑苷脂) (+1.4%), Cerdelga (Eliglustat, 葡萄糖神经酰胺合成酶) (+13.9%), Myozyme (阿糖苷酶 a, 糖原) (+7.4%), Fabrazyme (半乳糖苷酶法, 脂质) (+6.8%), Aldurazyme (+8.2%), 主要是全球三个地理区域 (美国, 欧洲和其他地区) 的销售增长驱动。
- Fabrazyme (半乳糖苷酶, 脂质) 上半年治疗法布瑞氏症的销售额为 4.12 亿欧元, 同比增长 6.8%; 第二季度销售额 2.04 亿欧元, 增长了 9.0%, 欧洲市场 (+17.4%)、世界其他地区 (+9.8%) 和美国市场 (+4.9%) 的销售额增加, 推动力来源于新患者的应计和改善了所有地区的治疗依从性。

图表 10: 2021H1 罕见病药物收入及增速



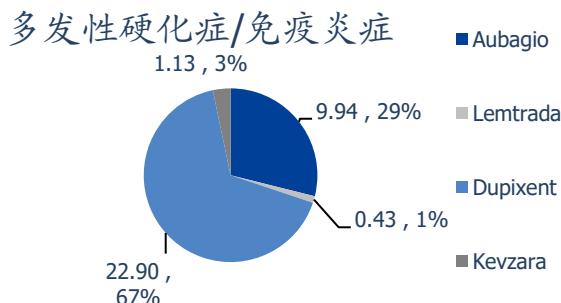
资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

多发性硬化症/免疫炎症

- **2021H1 收入总体同比增长 27.9% (CER)**, 主要依赖于 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 销售额同比增长 51.4%, 两大药物继续承压, Aubagio 销售额下降 0.7%, Lemtrada 销售额同比下降 30.9%。
- 上半年 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 用于湿疹治疗的销售额达到 22.9 亿欧元, 增长 51.4%。上半年末, Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 在 **53** 个国家推出, 超过 **300,000** 名患者了接受治疗。
- 上半年 Kevzara (Sarilumab, IL-6R) (与再生元合作) 用于治疗类风湿性关节炎的

销售额为 1.13 亿欧元，同比上调了 1.7%。2021Q2 销售额为 0.56 亿欧元，同比下降了 6.5%，原因是最近减少促销活动的战略决定，导致美国和世界其他地区的销售额下降。

图表 11: 多发性硬化症/免疫炎症药物销售额 (亿欧元)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

抗肿瘤药物

- 上半年的销售额增长了 **25.6% (CER)**，这主要得益于 Sarclisa (isatuximab-irfc, CD38) (1460.0%) 和 Libtayo (cemiplimab-rwlc, PD-1) (122.2%)，Fasturtec (rasburicase, -) (+8.3%) 销售额增长，这远远抵消了 Jevtana (卡巴他赛，微管蛋白) (-5.9%) 在欧洲仿制药竞争的影响。
- 继 3 月底某些欧洲市场进入仿制药竞争 (-26.8%) 之后，第二季度 Jevtana (卡巴他赛，微管蛋白) 治疗激素难治性前列腺癌的销售额为 1.14 亿欧元，下降 9.0%，在美国，销售额增长了 **6.3%**，Jevtana (卡巴他赛，微管蛋白) 物质成分专利将于 **2021 年 9 月到期**。

罕见血液病

- 罕见血液病上半年销售额稳定，排除 sobi 的销售额，在 CER 下同比增长 **11.1%**，依赖于 Cablivi (cemiplimab-rwlc, von Willebrand factor) (+71.2%)，销售压力来自 Alprolix(凝血因子 IX) (-4.0%)，Eloctate(抗血友病因子) (-8.5%)。
- Eloctate(抗血友病因子)上半年治疗 **A 型血友病** 的销售额为 2.78 亿欧元 (-8.5%)；第二季度销售额为 1.44 亿欧元，下降 7.1%，不包括对 Sobi 的工业销售，Eloctate(抗血友病因子)的销售额增长了 **6.8%**，这得益于美国销售额的增长 (**+7.0%**)。
- Alprolix(凝血因子 IX)上半年治疗 **B 型血友病** 的销售额为 2.00 亿欧元 (-4.0%) (-4.0%)；第二季度销售额下降 **6.0% 至 1 亿欧元**。不包括对 Sobi 的工业销售额，Alprolix(凝血因子 IX) (-4.0%) 销售额增长了 **15.8%**，主要是由于患者从标准半衰期因素和预防性转换的转变，以及由于第二季度 COVID-19 的影响导致比较基数较低。
- Cablivi (cemiplimab-rwlc, von Willebrand factor) 上半年用于治疗 **血栓性血小板减少性紫癜** 的销售额为 0.84 亿欧元 (+71.2%)；第二季度的销售额为 4600 万欧元 (+75.0%)，在美国，该产品的销售额为 **2100 万欧元 (增长 27.8%)**，在欧洲，销售额为 **2500 万欧元 (+150.0%)**，主要是由于在更多国家/地区推出。

胰岛素

- 上半年总体销售额下降 **0.1% (CER)**，主要是由于 Lantus (甘精胰岛素, 胰岛素受体、IGF-1R) 销售额 (-3.2%) 下降抵消了 Toujeo(甘精胰岛素, 胰岛素受体) (+6.5%) 和 Soliqua(甘精胰岛素+利西拉来, 胰岛素受体, GLP-1) (+29.3%) 的增长，其他种类销售额下降 2.3%。

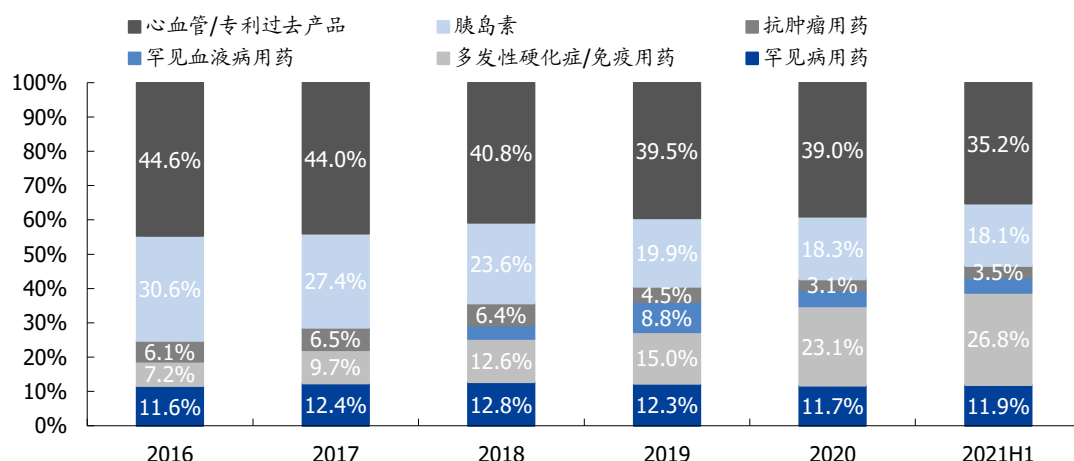
治疗糖尿病

- Toujeo(甘精胰岛素,胰岛素受体)上半年销售额为 5.00 亿欧元 (+6.5%); 第二季度销售额增长 7.9%至 2.47 亿欧元, 因为世界其他地区的销售额增长, 中国地区具有优秀表现, 以及 2020 年第二季度欧洲地区销售低迷。
- Lantus(甘精胰岛素,胰岛素受体、IGF-1R)上半年销售额为 12.89 亿欧元 (-3.2%); 第二季度销售额为 6.37 亿欧元, 下降 2.7%, 主要是由于更多新患者开始使用生物仿制药甘精液竞争导致世界其他地区和欧洲的销售额下降。Lantus(甘精胰岛素,胰岛素受体、IGF-1R)在美国的销售额增长了 6.6%, 主要是由于销量增加。
- Soliqua(甘精胰岛素+利西拉来,胰岛素受体,GLP-1)上半年销售额为 0.90 亿欧元 (+29.3%); 第二季度销售额增长 28.9%至 4600 万欧元, 主要是由于在世界其他地区的推出 (+50.0%) 和欧洲的表现 (+40.0%)。

新血管/专利过期

- 上半年销售收入总体为 45.17 亿欧元, 下降了 0.4% (CER)。Praluent(阿利库单抗,PCSK9)下降 27.4%, Aprovel(厄贝沙坦,血管紧张素 II 受体)下降 32.7%, Plavix(氯吡格雷, P2Y-12)下降了 1.2%, Lovenox(依诺肝素,抗凝血酶)上升了 27.6%, Thymoglobulin(甲状腺球蛋白,T 淋巴细胞)上升了 22.8%, Mozobil(普乐沙福,CXCR4、CXCR7)上升了 17.2%, Multaq(决奈达隆,钾离子通道)上升了 6.5%, 仿制药上升了 4.5%, 其他心血管药物下降了 5.4%。
- Lovenox(依诺肝素,抗凝血酶)用于治疗急性冠状动脉综合征, 上半年销售额为 7.68 亿欧元 (+27.6%); 第二季度销售额为 3.67 亿欧元, 同比增长 24.6%, 受欧洲 (+43.3%) 和世界其他地区 (+13.8%) 的强劲销售推动。
- Plavix(氯吡格雷, P2Y-12)用于预防急性冠状动脉综合征等, 上半年销售额为 4.85 亿欧元 (-1.2%); 第二季度销售额增长 2.1%至 2.34 亿欧元, 主要反映了欧洲和世界其他地区销售额的增长, 在中国的销售额为 9400 万欧元, 增长了 8.0%, 抵消了日本销售额的下降。
- Aprovel/Avapro(厄贝沙坦,血管紧张素 II 受体)用于治疗高血压, 上半年销售额为 2.00 亿欧元 (-32.7%); 第二季度销售额下降 23.5%至 9900 万欧元, 主要由于短期供应限制。
- Praluent(阿利库单抗,PCSK9)用于治疗动脉粥样硬化、家族性高胆固醇血症动脉粥样硬化、家族性高胆固醇血症, 上半年销售额为 1.04 亿欧元 (-27.4%); 第二季度销售额下降 34.2%至 4800 万欧元。赛诺菲对美国以外的地区 Praluent(阿利库单抗,PCSK9)销售全权负责。
- Multaq(决奈达隆,钾离子通道)用于治疗心律失常, 上半年销售额为 1.51 亿欧元 (+6.5%); 第二季度销售额为 7900 万欧元, 增长 17.8%, 这得益于 HCP 参与度的增加, 因为随着美国市场从大流行中复苏, 对抗心律失常药物的需求增加。

图表 12: 药品销售收入分类 (%)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

疫苗业务

上半年疫苗销售 **19.37 亿欧元**, 在 **CER** 下增长了 **10.8%**, 由于美国脑膜炎疫苗销售和儿科组合销售的复苏以及南半球流感季节较多, 抵消了 **COVID-19** 对旅行疫苗的持续负面影响。疫苗各类销售额变化: Influenza vaccines (+14.0%), Polio/Pertussis/Hib vaccines (+3.8%), Meningitis/Pneumo vaccines (+53.2%), Adult Booster vaccines (+11.9%), Travel and Other Endemic Vaccines (-9.7%), 其他疫苗 (+25.8%)。

- 上半年, 疫苗的营业收入 (BOI) 为 5.98 亿欧元, 增长 32.9% (按 CER 计算增长 41.1%), 由于强劲的销售以及第一三共在 2021 年第一季度的付款。BOI 与净销售额的比率增长了 6.4 个百分点至 30.9% (CER 为 31.2%)。
- 流感疫苗上半年销售额为 1.96 亿欧元 (+14.0%); 第二季度销售额增长了 8.6%, 达到 1.19 亿欧元。
- 脑膜炎疫苗上半年销售额为 3.14 亿欧元 (+53.2%); 第二季度销售额增长 125.8% 至 1.06 亿欧元, 主要由于美国 2021 年 3 月推出 MenQuadfi 相结合。
- 成人加强疫苗 (破伤风疫苗) 上半年销售额为 2.06 亿欧元 (+11.9%); 第二季度销售额增长 42.3% 至 1.86 亿欧元, 原因是美国的 Adacel 疫苗接种增多。
- 旅行和其他地方性疫苗上半年销售额为 **1.33 亿欧元 (-9.7%)**; 第二季度销售额增长 **40.0%**, 主要是由于世界其他地区的黄热病疫苗 (地方性疫苗) 销售额增加, 这在很大程度上抵消了旅行限制持续影响导致的旅行相关疫苗的低销售额全球。

消费者保健业务

上半年消费保健 (CHC) 销售额 **22.02 亿欧元**, 在 **CER** 下, 同比增长 **1.2%**, 主要是由于消化健康的销售额增长抵消了咳嗽和寒冷季节的疲软以及非核心产品的撤资 (-0.6 个百分点的影响)。消费保健业务销售额变化: Allergy (-2.6%); Cough, Cold and Flu (-46.0%); Pain Care (2.4%); Digestive Wellness (24.6%); Physical Wellness (-4.6%); Mental Wellness (21.3%); Personal Care (1.5%); Non-Core/Others (-10.4%)。

- **2021 年上半年, CHC 的 BOI 下降 6.8% (按 CER 计算增长 2.2%) 至 7.31 亿欧元。BOI 与净销售额的比率下降 0.5 个百分点至 33.2% (CER 为 34.1%)。**
- 作为赛诺菲简化其 CHC 产品组合并加速其增长轨迹的持续努力的一部分, 赛诺菲于 6 月与 STADA 签署了一项协议, 以剥离在欧洲商业化的 16 个 CHC 非核心品牌。

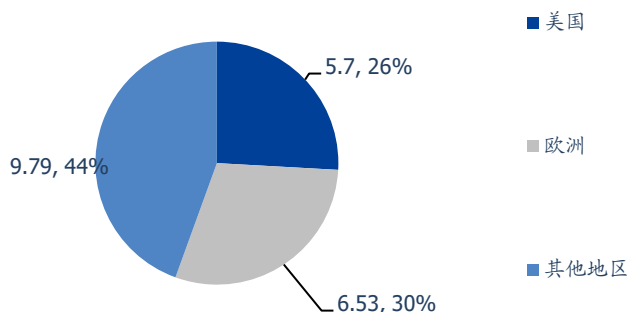
CHC 业务分地区表现

- 在美国, 上半年 **CHC 销售额为 5.70 亿欧元 (+13.3%)**; 第二季度销售额增长 12.5% 至 2.87 亿欧元受益于 Dulcolax 业绩的消化健康业务的销售额推动。

- 在欧洲，上半年 **CHC** 销售额为 **6.53 亿欧元 (-8.1%)**；第二季度销售额增长 7.7% 至 3.19 亿欧元，主要是由于 Doliprane 销售额增加以及消化和心理健康类别的强劲表现推动了疼痛护理的强劲增长，这足以抵消咳嗽的销售额下降、感冒和流感类别因为社会疏远措施的影响。
- 在世界其他地区，上半年 **CHC** 销售额为 **9.79 亿欧元 (+4.2%)**；第二季度销售额增长 14.3% 至 4.83 亿欧元，反映了主要由 Enterogermina、Buscopan 和 Essentiale 推动的消化健康的强劲增长，以及疼痛护理、心理健康和过敏类别。

图表 13: 2021H1 消费保健 (亿欧元)

2021H1 消费保健 (亿欧元)



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

图表 14: 公司药品收入及增值 (亿欧元)

药物商品名	药物通用名	适应症	靶点	获批	专利过期	2021Q2	增速	2021H1	增速
药品总计						6 个月合计	131.96	增速	7.7%
罕见病用药						6 个月合计	15.29	增速	6.5%
Cerezyme	重组葡萄糖苷酶	1 型戈谢病	葡萄糖脑苷脂	1994	-	1.65	-1.7%	3.43	1.4%
Cerdelga	Eliglustat	戈谢病	葡萄糖神经酰胺合成酶	2014	2022	0.61	14.0%	1.23	13.9%
Myozyme	阿糖苷酶 a	糖原贮积病 II 型	糖原	2006	2015	2.48	14.6%	4.83	7.4%
Fabrazyme	半乳糖苷酶	法布瑞氏症	脂质	2003	2015	2.04	9.0%	4.12	6.8%
Aldurazyme	拉罗尼酶	1 型黏多糖贮积症	硫酸皮肤素	2005	2019	0.57	9.1%	1.23	8.2%
多发性硬化症/免疫炎症						6 个月合计	34.40	增速	27.9%
Aubagio	特立氟胺	多发性硬化症	二氢乳清酸脱氢酶	2012	-	4.94	-0.4%	9.94	-0.7%
Lemtrada	阿伦单抗	多发性硬化症	CD52	2014	-	0.19	5.3%	0.43	-30.9%
Dupixent	Dupilumab	湿疹	IL-4R	2017	-	12.43	56.6%	22.90	51.4%
Kevzara	Sarilumab	类风湿性关节炎	IL-6R	2017	2020	0.56	-6.5%	1.13	1.7%
罕见血液病用药						6 个月合计	5.62	增速	5.3%
Eloctate	抗血友病因子	A 型血友病	-	2014	2024	1.44	-7.1%	2.78	-8.5%
Alprolix	凝血因子 IX	B 型血友病	-	2017	2024	1.00	-6.0%	2.00	-4.0%

Cabliivi	Caplacizumab	血栓性血小板减少性紫癜	von Willebrand factor	2018	2035	0.46	75.0%	0.84	71.2%
抗肿瘤用药						6 个月合计	4.47	增速	25.6%
FASTURTEC	rasburicase	肿瘤患者高尿酸血	-	-	-	0.39	8.1%	0.74	8.3%
Jevtana	卡巴他赛	激素难治性前列腺癌	微管蛋白	2010	2012	1.14	-9.0%	2.40	-5.9%
Sarclisa	isatuximab-irfc	多发性骨髓瘤	CD38	2020	-	0.40	975.0%	0.74	1460.0%
Libtayo	cemiplimab-rwlc	各类肿瘤	PD-1	2018	-	0.33	120.0%	0.59	122.2%
胰岛素						6 个月合计	23.21	增速	-0.1%
Lantus	甘精胰岛素	糖尿病	胰岛素受体、IGF-1R	2001	2010	6.37	-2.7%	12.89	-3.2%
Toujeo	甘精胰岛素	糖尿病	胰岛素受体	2015	2024	2.47	7.9%	5.00	6.5%
Apidra	谷赖胰岛素	糖尿病	胰岛素受体	2004	2015	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Soliqua	甘精胰岛素+利西拉来	糖尿病	胰岛素受体、GLP-1	2020	-	0.46	28.9%	0.90	29.3%
其他	-	-	-	-	-	2.16	3.7%	4.42	-2.3%
心血管/专利过期品种						6 个月合计	45.17	增速	-0.4%
Praluent	阿利库单抗	动脉粥样硬化、家族性高胆固醇血症	PCSK9	2015	-	0.48	-34.2%	1.04	-27.4%
Multaq	决奈达隆	心律失常	肾上腺素能受体、钾离子通道	2009	2016	0.79	17.8%	1.51	6.5%
Lovenox	依诺肝素	急性冠状动脉综合症	抗凝血酶	1998	-	3.67	24.6%	7.68	27.6%
Plavix	氯吡格雷	预防急性冠状动脉综合征等	P2Y-12	1997	-	2.34	2.1%	4.85	-1.2%
Aprovel	厄贝沙坦	高血压	血管紧张素 II 受体	1998	-	0.99	-23.5%	2.00	-32.7%
Renvela	碳酸司维拉姆	慢性肾病血液透析引起的高磷血症	磷酸盐	2007	-	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Synvisc	玻尿酸	膝关节关节炎	-	1997	-	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Thymoglobulin	甲状腺球蛋白	器官移植	T 淋巴细胞	2017	-	0.92	51.6%	1.72	22.8%
Eloxatine	奥沙利铂	结肠直肠癌	DNA	2002	-	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Taxotere	多西他赛	肺癌、前列腺癌等	微管蛋白、bcl-2	1999	2010	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Mozobil	普乐沙福	淋巴瘤、多发性骨髓瘤	CXCR4、CXCR7	2008	2018	0.58	35.6%	1.10	17.2%
其他仿制药	-	-	-	-	-	1.88	5.8%	3.94	4.5%
其他心血管用药	-	-	-	-	-	10.43	2.9%	21.33	-5.4%
工业销售						6 个月合计	3.80	增速	5.1%

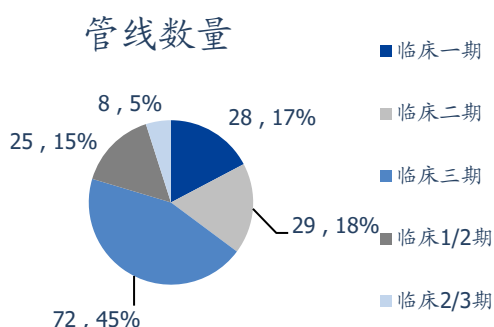
工业销售	-	-	-	-	-	1.92	1.6%	3.80	5.1%
疫苗						6个月合计	19.37	增速	10.8%
Influenza vaccines	流感疫苗	流感	-	-	-	1.19	8.6%	1.96	14.0%
Polio/Pertussis/Hib vaccines	骨髓灰质炎、百日咳、流感嗜血杆菌疫苗	骨髓灰质炎、百日咳、流感嗜血杆菌	-	-	-	5.20	-5.6%	10.53	3.8%
Meningitis/Pneumo vaccines	脑膜炎、伤寒疫苗	脑膜炎、伤寒	-	-	-	1.86	125.8%	3.14	53.2%
Adult Booster vaccines	破伤风疫苗	破伤风	-	-	-	1.06	42.3%	2.06	11.9%
Travel and Other Endemic Vaccines	-	-	-	-	-	0.74	40.0%	1.33	-9.7%
其他疫苗	-	-	-	-	-	0.17	35.7%	0.35	25.8%
消费健康产品						6个月合计	22.02	增速	1.2%
消费健康产品	-	-	-	-	-	10.89	11.9%	22.02	1.2%

资料来源：赛诺菲公司公告，国盛证券研究所

研发进展

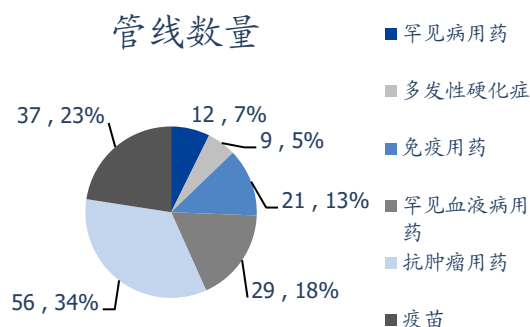
- 公司 2021H1 研发费用 26.63 亿欧元，同比下降了 1.1%，研发费用率为 15%。
- 目前研发管线包含 164 个临床项目，其中 28 个临床一期，29 个临床二期，72 个临床三期，1 个临床四期，25 个临床 1/2 期，8 个临床 2/3 期项目。
- 公司研发管线中，免疫领域相关 21 个，肿瘤治疗领域相关 56 个，多发性硬化症和神经相关 9 个，罕见病相关 12 个，罕见血液病 29 个，疫苗领域管线 37 个。

图表 15: 临床阶段管线占比



资料来源：赛诺菲公司公告，国盛证券研究所

图表 16: 不同疾病领域管线占比



资料来源：赛诺菲公司公告，国盛证券研究所

审批进展

- Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 治疗中度至重度特应性皮炎成人进行的研究的长期安全性数据将被添加到 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 产品特性摘要中 (SmPC)。
- Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 的 200 毫克单剂量预装笔，获 FDA 批准。用于 12 岁及以上患者的所有 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 适应症，预计将于 2021 年 8 月在美国上市，并为处方 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 的成人和青少年提供额外的给药选择。300 毫克剂量的预装笔先前已获得 FDA 批准。
- Libtayo (cemiplimab-rwlc, PD-1) 作为两种晚期癌症 (非小细胞肺癌，局部晚期或转移性基底细胞癌(BCC)) 的单一疗法，2021 年 6 月 25 日获欧盟委员会(EC) 批准。

- **Libtayo (cemiplimab-rwlc, PD-1)** 用于晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗, 2021 年 2 月 22 日获美国食品和药物管理局 (FDA) 批准。
- **Sarclisa (isatuximab-irfc, CD38)** 治疗复发性多发性骨髓瘤的适应症, 2021 年 4 月 19 日获欧盟委员会(EC)批准。
- **Aubagio (teriflunomide)** 用于治疗 10-17 岁复发缓解型多发性硬化症(RRMS)的儿科患者, 2021 年 6 月 18 日获欧盟委员会(EC)批准。
- **Rilzabrutinib (BTK 抑制剂)** 治疗寻常型天疱疮, FDA 授予快速开发通道。Rilzabrutinib (BTK 抑制剂) 处于 3 期开发阶段。
- **Shan6**, 一种用于儿科患者预防六种疾病 (白喉、破伤风、百日咳、脊髓灰质炎、乙型肝炎和 b 型流感嗜血杆菌) 的全细胞百日咳联合疫苗已获得印度当局的市场许可, 计划于 2022 年推出。
- **2021 年 6 月 29 日**, 赛诺菲推出了首个专门的疫苗 mRNA 卓越中心。赛诺菲将汇集大约 400 名员工, 将端到端的 mRNA 疫苗能力与专门的研发、数字化、化学、制造和控制(CMC)团队相结合。
- **SoliMix 研究证明, Soliqua(甘精胰岛素+利西拉来,胰岛素受体,GLP-1)**对于血糖 (HbA1c)降低和体重变化不劣于预混胰岛素, 该研究结果于 6 月在美国糖尿病协会 (ADA)上发表, 并同时发表在糖尿病护理杂志上。

临床 I 期

- **SP0273 (mRNA 单价流感疫苗候选者, 编码 A/H3N2 病毒株的血凝素蛋白流感病毒)** 开始了一项评估安全性和免疫原性的试验。
- **SAR444881 (抗 ILT2)** 正在与 Biond 合作在实体瘤中进行测试。
- **Sutimlimab (补体 C1s 抑制剂)** 在免疫性血小板减少性紫癜中被停用。
- **SAR441236 (用于 HIV 开发的三特异性药物)** 已授权 ModeX Therapeutics 进行开发, 除了与 DAIDS/NIH 赞助的正在进行的临床试验 (A5377) 相关的一些保留义务外, ModeX 将进行开发。

临床 II 期

- **Sarclisa (isatuximab-irfc, CD38)** 开展了一项与新药联合治疗复发难治性多发性骨髓瘤的 1/2 期试验, 组合包括 SAR439459 (抗 TGFb 抗体) 和 belantamab (BLENREP, BCMA)。
- **Tusamitamab ravtansine (抗 CEACAM5 抗体药物偶联物)** 在 CEACAM5 阳性晚期实体瘤患者中开展了 2 期试验 (CARMEN-BT01)。
- **SAR445229(抗 OX40L)**, 在收购 Kymab 完成后进入赛诺菲的产品线, 计划于 2021 年开展一项针对特应性皮炎的 2b 期研究。
- **SAR441344(抗 CD40L)**开展了复发性多发性硬化症的 2 期试验。
- **SAR443122(外周限制性 RIPK1 小分子抑制剂)**开展了一项皮肤红斑狼疮 (CLE) 2 期研究。
- **SAR445256(抗 ICOS)**在 Kymab 的收购完成后进入临床二期。
- **SAR445088 (补体 C1 抑制剂)**展开了对慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP) 患者进行研究。
- **SP0218 (黄热病的 vero 细胞疫苗)**在美国开展了一项针对成年人的研究。

临床三期

- **SP0253 (重组蛋白 COVID-19 候选疫苗)**, 赛诺菲和葛兰素史克开始了一项 临床 3 期研究。722 名志愿者在所有成人年龄组的第 2 阶段表现出很强的中和抗体反应率, 这与在从 COVID-19 中康复的人中测量的结果一致。
- **Nirsevimab (延长半衰期的 RSV 抗体)** 的 3 期试验 (MELODY) 证明了对健康婴儿的呼吸道合胞病毒 (RSV) 疾病的保护作用。MELODY、MEDLEY 和 2b 期试验将构成计划于 2022 年开始的监管提交的基础。
- **Sutimlimab (C1s 研究抑制剂)** 的新关键数据 (CADENZA), 有可能成为首个获批治疗冷凝血素病患者溶血的药物。

- **venglustat (GL-1)** 治疗常染色体显性遗传多囊肾病 (ADPKD) 的关键 2/3 期研究不符合无效标准，赛诺菲已停止 ADPKD 的临床计划。
- **Libtayo (cemiplimab-rwlc, PD-1)** 单药治疗宫颈癌复发或转移的患者三期临床，2021 年 3 月 15 日公布与先前接受化疗的患者相比，总体生存率 (OS) 受益。

图表 17: 公司重要研发项目进度安排及实际完成情况

	Product	Milestones	Comment	Achieved / Missed ⁽¹⁾
H1 2021	avalglucosidase alfa	U.S. regulatory decision, PDUFA May 18 (Pompe disease)	Fast track designation, BTB, Priority review	✗ H2 2021 ⁽³⁾
	Libtayo ^{®(2)}	U.S. regulatory decision, PDUFA Feb 28 (1L NSCLC PD-L1 ≥50%)	Priority review	✓
	Libtayo ^{®(2)}	U.S. regulatory decision, PDUFA March 3 (advanced BCC)	Priority review	✓
	Sarclisa [®]	U.S. regulatory decision PDUFA July 18 (RMM-1KEMA)		✓
	amcenestrant	Pivotal data from AMEERA-3 in 2/3L mBC	Fast track designation	✗ H2 2021 ⁽⁴⁾
	Libtayo ^{®(2)}	Pivotal data in 1L NSCLC combo with chemotherapy		✗ H2 2021 ⁽⁴⁾
	Libtayo ^{®(2)}	Pivotal data in 2L Cervical Cancer		✓
	amcenestrant	Phase 3 decision for early breast cancer	Fast track designation	✓
H2 2021	avalglucosidase alfa	EU regulatory decision (Pompe disease)		
	Dupixent ^{®(2)}	U.S. regulatory decision (Asthma 6 to 11-year)		
	Sarclisa [®]	EU regulatory decision (Relapsed Multiple Myeloma - 1KEMA)		✓
	Dupixent ^{®(2)}	Pivotal trial read-out (Chronic Spontaneous Urticaria - CSU)		✓
	Dupixent ^{®(2)}	Pivotal trial read-out (Prurigo Nodularis - PN)		
	rilzabrutinib	Pivotal trial read-out (Pemphigus)	U.S. and EU orphan designation	
	Sarclisa [®]	Pivotal trial read-out (1L TiMM- IMROZ)		
2021	Adding multiple NMEs in Immunology, Oncology, and RBD in 2021 to the clinical pipeline			

资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

Libtayo (cemiplimab-rwlc, PD-1): 2021 年 2 月 12 日《柳叶刀》公布了一项关键性试验的结果，该试验旨在评估 PD-1 抑制剂 Libtayo[®] (cemiplimab) 与铂双重化疗在局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 合并肺癌患者 (肿瘤细胞≥50%的 PD-L1 表达) 中的研究应用。该分析表明，与化疗相比，**Libtayo 降低了 43% 的死亡风险。**

Sarclisa (isatuximab-irfc, CD38): 2021 年 3 月 31 日—美国食品和药物管理局 (FDA) 已批准 **Sarclisa[®] (isatuximab)** 与卡非佐米布和地塞米松 (Kd) 联合治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤 (RRMM) 的成年患者，这些患者接受过一到三种先前的治疗。在本研究中，多发性骨髓瘤患者接受 Sarclisa 联合 Kd 治疗与单独使用标准治疗 Kd 治疗相比，疾病进展或死亡的风险降低了 **45%** (危险比=0.548, 95%CI =0.366-0.822, p=0.0032)。在进行预先计划的中期分析时，**Sarclisa 联合疗法的中位无进展生存期 (PFS) 尚未达到。**

Sarclisa 与对照组相比，最常见的不良反应 (发生在 20% 或以上的患者中) 为上呼吸道感染 (67% VS 57%)、输液相关反应 (46% VS 3.3%)、疲劳 (42% VS 32%)、高血压 (37% VS 32%)、腹泻 (36% VS 29%)、肺炎 (36% VS 30%)、呼吸困难 (29% VS 24%)、支气管炎 (24% VS 13%) 和咳嗽 (23% VS 15%)。在接受 Sarclisa 联合治疗的患者中，5% 以上发生的严重不良反应为肺炎 (25%) 和上呼吸道感染 (9%)。8% 接受 Sarclisa 联合治疗的患者因不良反应 (1-4 级) 而永久中断治疗，2.8% 的患者因感染而中断治疗。

Dupixent (Dupilumab, IL-4R): Dupixent 是一种全人类单克隆抗体，可抑制白细胞介素 4 (IL-4) 和白细胞介素 13 (IL-13) 途径的信号传导，不是免疫抑制剂。IL-4 和 IL-13 是 2 型炎症的关键和中心驱动因素，2 型炎症在哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉病 (CRSwNP)、特应性皮炎、嗜酸性食管炎中起主要作用，也可能与重度慢性自发性荨麻疹 (CSU) 有关。

2021 年 7 月 29 日公布 Dupixent 治疗炎症性皮肤病中重度慢性自发性荨麻疹 (CSU) 患者数据，在 24 周时达到其主要终点和所有主要次要终点。与 LIBERTY CUPID 临床项目研究 A (两个试验中的第一个) 中单独使用抗组胺药 (安慰剂) 的患者相比，在标准护理抗组胺药中添加 **Dupixent** 可显著减少生物性天然患者的瘙痒和荨麻疹。

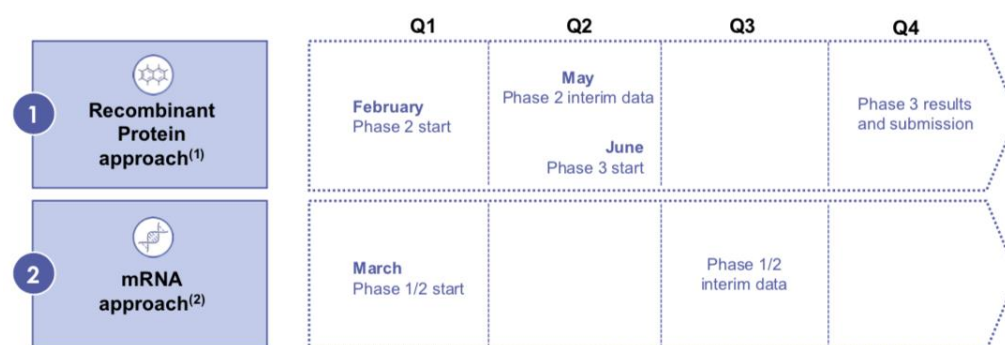
CSU 的结果进一步证明了通过 IL-4Ra 阻断以 IL-4 和 IL-13 为靶点改善具有 2 型炎症成分的疾病的潜力。美国约有 300000 人患者，仅抗组胺药治疗无效。

- 通过 0-21 点瘙痒严重程度量表测量 (Dupixent 组瘙痒严重程度降低 10.24 点, 标准护理组瘙痒严重程度降低 6.01 点), Dupixent 组瘙痒严重程度降低 63%, 而标准护理组瘙痒严重程度降低 35% ($p < 0.001$), 这是美国的主要终点 (欧盟的次要终点), 持续改善到第 24 周。
- 通过 0-42 点荨麻疹活动量表测量, Dupixent 组荨麻疹活动 (瘙痒和荨麻疹) 严重程度降低 65%, 标准护理组为 37% (Dupixent 组为 20.53 点, 标准护理组为 12.00 点) ($p < 0.001$), 这是欧盟的主要终点 (美国的次要终点) 持续改善至第 24 周。

Amcenestrant (选择性内质网降解剂 (SERD)): Amcenestrant 是一种口服选择性雌激素受体降解剂 (SERD), 与帕博昔布联合进行的 1 期临床数据 (AMERA-1) 在 2021 年美国临床肿瘤学会 (ASCO) 年会上公布。在每天服用 200mg Amcenestrant 的混合人群中 ($n=35$), 客观缓解率 (ORR) 为 34% (90%CI: 21.1-49.6), 12/35 患者证实部分缓解 (PR), 临床受益率 (CBR) 为 74% (90%CI: 59.4-85.9), 24 周时临床受益 26/35 的患者。每日 200mg 的 Amcenestrant 与帕博昔布联合使用显示出良好的总体安全性 ($n=39$)。

Amcenestrant 与 palbociclib 的第三阶段一线联合研究 (AMERA-5) 于 2020 年 10 月启动, 目前正在招募患者。(AMERA-3) Amcenestrant 与医生选择治疗局部晚期或转移性雌激素受体阳性 (ER+) 乳腺癌的关键研究数据, 预计 2021 年下半年的读数。

图表 18: 新冠疫苗研发进展



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

FIC 或 BIC 管线

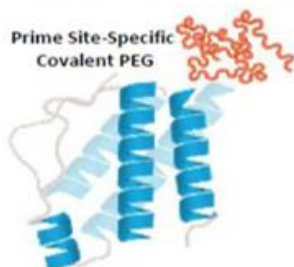
- 2017 年 FIC 和 BIC 管线占比 68%, 2021 年 FIC 和 BIC 管线占比增加到 89%。
- Amcenestant (选择性内质网降解剂 (SERD) 治疗乳腺癌, 具有多种 BIC 优势: 无剂量限值毒性; 安全性可靠; 较强的抗肿瘤活性, ORR 为 34.3%, CBR 为 74.3% (ASCO 2021 年的组合数据); 首个口服 SERD 辅助设置。
- Tolebrutinib (BTK 抑制剂) 治疗多发性硬化症。在一项 II 期临床研究中, 复发缓解型多发性硬化症患者服用安慰剂 4 周之前或之后, 服用 4 种剂量的 Tolebrutinib 中的一种, 为期 12 周。与安慰剂期相比, 使用最高剂量的 Tolebrutinib 治疗可使新的 T1 病变相对减少 85%, T2 病变相对减少 89%。T1 病变是活动性、持续性炎症的区域; T2 病变是炎症导致损伤的区域。
- Efanesoctocog alfa (investigational factor VIII replacement therapy) 治疗血友病 A。Efanesoctocog alfa 是一种新型融合蛋白, 基于创新的 Fc 融合技术开发, 通过添加 vWF 的一个区域和 XTEN® 多肽来延长其在血液循环中的时间。在 A 型血友病临床前模型中, efanesoctocog alfa 的止血控制效果比 rFVIII 高 4 倍, 该药有望为重度 A 型血友病患者提供针对所有出血类型的更优、更广泛的保护。
- SAR'245(抗 IL-2)治疗实体瘤, 有效的扩增 CD8+T 细胞和 NK 细胞, 不会引起肿瘤

抑制性 Treg 细胞增殖。

- SAR'229 (抗 Ox40L) /SAR'656 (IRAK4 降解剂) /SAR'727 (BTKi 外用) 治疗特应性皮炎。

图表 19: SAR'245: 潜在的 BIC IL-2

SAR'245: Potential best-in-class IL-2



- First patient in skin⁽¹⁾ and lung⁽²⁾ trials expected shortly
- Head and neck plus 2 additional basket trials to start by year end

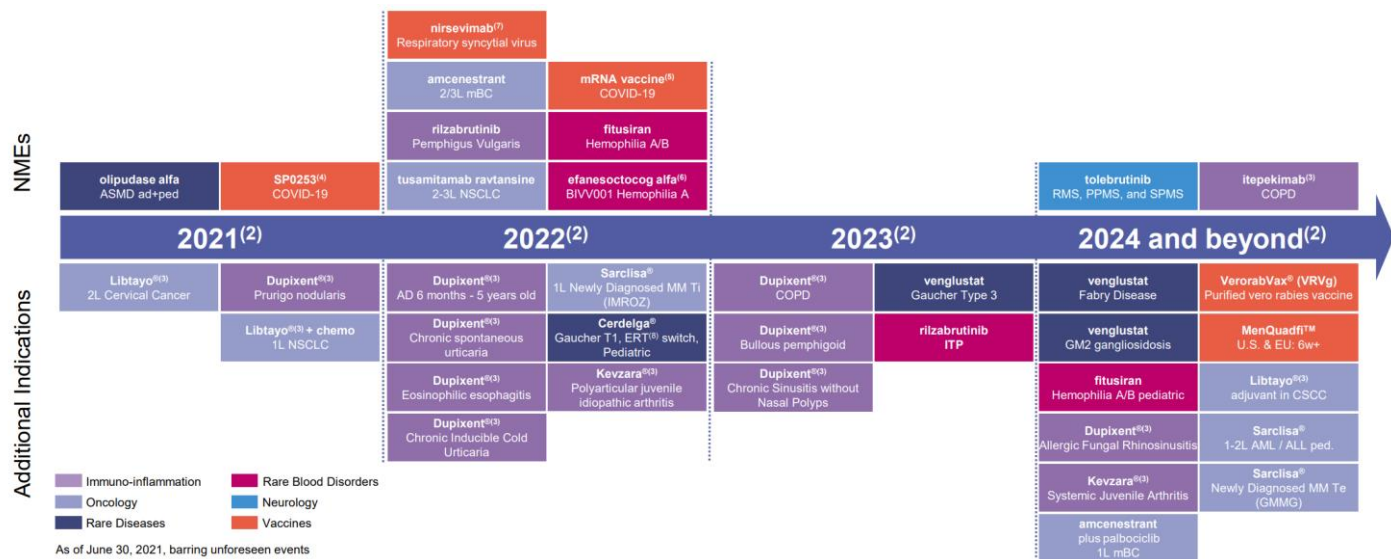
资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

图表 20: 预计 2021 年下半年将实现关键的制药研发里程碑

CANDIDATE	INVESTIGATIONAL INDICATION(S)	MILESTONES
Dupixent ^{®(1)}	Prurigo nodularis Eosinophilic esophagitis Atopic Dermatitis	• Phase 3 data • Phase 3 Part B data • Phase 3 data in <6yo
Amcenestrant	ER+ breast cancer	• Phase 2 pivotal data in 2L/3L monotherapy (AMEERA-3) • Phase 3 trial in adjuvant patients to start (AMEERA-6)
Sarclisa [®]	Multiple myeloma	• Phase 1/2 SC formulation • Phase 3 MRD induction data (GMMG) • Phase 3 data in 1L transplant ineligible (IMROZ)
Libtayo ^{®(1)}	1L Non-small-cell lung cancer	• Phase 3 data in combination with chemotherapy
Rilzabrutinib	Pemphigus Vulgaris Type 2 Inflammatory diseases	• Phase 3 data • Phase 2 trials to start in asthma, CSU, and atopic dermatitis
SAR'136 ⁽²⁾	Sickle cell disease	• Phase 1/2 interim data
SAR'229 ⁽³⁾	Atopic dermatitis	• Phase 2b trial to start; Phase 2 data presentation
SAR'245	Multiple tumor types	• Phase 2 programs in thoracic, skin, head and neck cancers to start • Phase 2 additional basket trials to start
Tolebrutinib	New indication	• Phase 2 trial start

资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

图表 21: 预期管线项目完成提交时间表



资料来源: 赛诺菲公司公告, 国盛证券研究所

Q&A

Q: 你认为最早什么时候可以更新你的中期财务目标?

A: 到 2025 年, BOI 利润率将趋向于 32%, 2022 年将趋向于 30%。我们将储蓄资金进行再投资, 增长和丰富管道数量。我们追求的是科学优先, 管道优先, 增长优先。

Q: 一种安全、干净的无副作用的高效口服药物是最大的未满足需求领域。在未来几年, 您认为特应性皮炎是否会有口服机制?

A: Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 的安全性和有效性设定了非常高的标准, 也添加了 CSU。我们对 Dupixent 的长期发展感到非常有信心。我们还有别的相近机制的管线, **Rilzabrutinib (BTK 抑制剂)** 和 **IRAK4 降解剂** 进入特应性皮炎的研究。我们有 **OX40-Ligand (OX40L 抗体) 注射剂**。患者对口服药非常感兴趣, 安全性和有效性将是选择的第一大理由。我们觉得随着时间的推移, 我们已经全面了解了患者的任何需求。我们在 2 月 5 日制定了计划, 在未来十年内增加了安全性和有效性研究。

Q: 关于 CSU, 如何看待能够使用 Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 药物的合适群体的发展?

A: 首先, 我们对 CSU 的第一个 III 期研究中的这些结果感到非常兴奋。那里有很多未满足的需求, 大量患者不受控制。我们认为生物群体应该是大约 **300,000** 名患者, 他们患有中度至重度疾病, 并且他们对标准护理 (仅抗组胺药) 没有足够的反应。现在是生物制剂的机会, 它目前尚未充分渗透。 **Omalizumab (IgG1k 单抗)**, 我们认为大约 15% 的符合条件的患者目前正在接受治疗。我们预计在随着时间的推移, 这一指标可能会翻倍, 接近 30%。所以我们有广阔的市场空间, 低的渗透率以及更好的性能。

Q: Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 的 CSU 数据具有较强的瘙痒的数据如何与对抗 lebrikizumab?

A: CSU 的数据非常的好, 我们对此非常满意。未来市场需求非常大, **lebri (IL-13)** 和其他 **IL-13** 的药物只是其中的一半。我们是靶向 IL-13 和 IL-4, 我认为我们在这个管线中是最好的。IL-13 不是一个完整的配体, 非常关键的是我们考虑到 IL-13 和 IL-4, 也反

映了 Dupixent 潜力的图景。

Q: Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 在注射频率上有没有设计方案?

A: 注射剂量对于产品销售不是挑战, 我们关注的是有效性和安全性其次是方便性。从销售业绩看, 它已经是站在安全性和有效性的顶端。

Q: Dupixent (Dupilumab, IL-4R) 在 CSU 和其他即将到来的试验中取得了良好的结果。您能否帮助我们思考一下您为 100 亿欧元目标制定的原始框架的触发因素是什么? 潜在修改的触发因素是什么?

A: 我们有 2 个产品收入。Dupixent, 解决 2 型 COPD 人群的问题; itepekimab (抗 IL-33), 关注非 2 型 COPD。2 型疾病, 有超过 300,000 名患者, 加上那些非 2 型前吸烟者, 就有超过 350,000 名患者。在这两种产品之间, 我们在没有其他可用生物制剂疗法的领域获得了一个非常有意义的近 700,000 名额外患者潜力。我们将在 23 年获得 Dupi 关键数据, 在 2024 年获得 itepekimab (抗 IL-33)。

Q: 关于欧洲的 avalglucosidase alpha (糖原), 我们可能会寻求批准什么样的延迟? 产品的定价策略?

A: 我们预计 CHMP 复审将在 2021 年第四季度的某个时间进行。我们不会对任何具体细节发表过多评论。我们相信它是一种新的活性物质。从定价的角度来看, 评论定价还为时过早。我们认为这将成为 Pompe 的主导产品。所以我们希望它会因该创新而得到认可。

Q: COVID-19 佐剂疫苗是两次注射方案吗? 在西方市场它有什么差异化的优势?

A: 初级方案是 2 剂方案。我们也在测试一剂的加强针。我们的产品都有机会成为室温下耐热的 1 剂加强剂。这些数据将在未来的 Q4 阶段的数据, 也就得出我们是什么样的产品。在全球范围内, 以后的时间肯定会看到我们的产品主要是助推器, 我们的数据很强大, 它会创造奇迹。

Q: mRNA 疫苗开展了单价的一期临床, 辉瑞公司四阶 mRNA 疫苗已经进入临床, 公司产品是否存在落后?

A: 我们想积极竞争, 因此我们建立了卓越中心。

Q: Rilzabrutinib (BTK 抑制剂) 从天疱疮读数中寻找治疗某些适应症的可能性, 比如哮喘和特应性皮肤病?

A: Rilza 有多种机制可以干扰过敏和自身免疫活动, 阻断 B 细胞受体信号传导, 阻断 FCR 受体信号传导。天疱疮和免疫性血小板减少性紫癜这两个适应症目前处于临床 III 期。基于这些数据, 我们在自身抗体驱动的疾病方面做得更多, 就扩展到其他一些适应症而言, 我认为在某些情况下有一些相似之处, 然后在其他情况下有一些差异。我们打算在许多适应症上测试 rilza。

Q: Rilzabrutinib (BTK 抑制剂) 开始哮喘、CSU 和 AD 的 II 期试验, 您能否帮助我们根据组合方法与顺序方法来理解这里的方法?

A: 对于 rilza 的联合疗法还为时过早。rilza 单一疗法, 根据 BTK 的中心性以及免疫生物学, 被认为是突出的细胞信号传导机制, 对哮喘等疾病产生切实的影响。

Q: amcenestrant (选择性内质网降解剂 (SERD)) 和 CDK4/6 之间看到的药物相互作用?

A: SERD 具有轻度至中度的 SIP 诱导, Palbo 改善了其与中等 SIP 诱导剂的使用。Palbo 由于其毒性特征, 通常不得不减少剂量, 并且至少有大约 1/3 的患者由于试图调整药物的副作用特征而不得不跳过剂量或减少剂量。所以我们觉得我们处于 200 毫克剂量的舒适区, 远远高于完全饱和雌激素受体所需的水平。ASCO 大会上提交的 I 期的数据显示出强大的整体响应率和领先的临床受益率, 我们更加相信这个组合可以继续前进。

Q: amcenestrant (选择性内质网降解剂 (SERD)) 关于优势的问题。罗氏公司提出的维罗尼卡研究，这是一项失败的研究。我们是否应该考虑使你的对照组患者可能与该研究中报告的有所不同？

A: 激素受体阳性乳腺癌的护理标准一直在发展，我们将测试 amcenestrant 的环境。我们正在测试的环境主要是 CDK4/6 抑制剂处理后的环境，目前尚无关于抗激素药物作为 CDK4/6 抑制剂后患者的单一疗法的任何数据，或者数据并不多。在这种情况下，我们的评估可能是内分泌治疗的第一个随机评估、随机临床试验评估。我们无法预测 PFS 将是什么，但我只想说明我们正在进行的是一项事件驱动的研究，该研究还没有达到足够的事件。我们倾向于 PFS4-6 个月。

Q: 关于 tolebrutinib (BTK 抑制剂)，我们可以在今年晚些时候或明年初看到这一点，以验证我们看到的强烈早期信号吗？

A: 我们有 ECTRIMS，将于 2021 年 10 月举行，我们将提供一些其他信息。我们在 6 月的 EAN 上，我们展示了有效的 BTK 调节小胶质细胞驱动神经炎症和 MS 进展。我们相信这是整个多发性硬化症 (MS) 谱中疾病潜在特征中最好的。

Q: 关于投资 mRNA 卓越中心的一个问题，4 亿欧元用于资本支出和研发支出以及此投资的特定计划？

A: 每年大约需要投资 4 亿欧元来加速下一代疫苗的端到端研发。它将通过资源重新分配获得全部资金。我们对临床前和早期临床项目进行了许多更改，专注于未来的潜力。

Q: 关于胰岛素 VBP，国家卫生保健部门召开了一次会议，讨论了 VBP 潜力的计划和反馈。从这个角度来看，您今天的基本情况期望是什么以及我们应该如何考虑时间和影响？

A: 确切的机制、范围和时间尚不清楚。鉴于我们在管理 VBP 方面的记录，我们现在有能力增加数量。我们已经能够在 Plavix 上增加数量，第一年大约增长了 90% 以上。我们在第二年继续增加销量，你在本季度看到了这一点。

Q: 欧洲 API，您是否可以从时间线的角度向我们提供一些增量细节，例如我们期望这家公司独立的时间？从您的角度来看，将其与赛诺菲分开并可能从中筹集一些资金的计划是什么？

A: 我们正在多方面有效地推动赛诺菲的转型。我们正在将消费者健康设置为一个独立的单元。我们正在通过分销商与许多地区的子公司来改变我们的商业足迹，因此涉及很多方面。Euro API 就是其中之一，而且完全走上正轨。我们在 19 年 12 月说过，我们的目标是在 2022 年上半年交付。分拆和财务也按计划进行。自从我们将其作为一个独立部门进行管理以来，该活动正在强劲改善，并且正在为 2022 年上半年的 IPO 做好准备。我们预计它对赛诺菲的增值影响非常小。我们主要不是为了金融游戏而这样做，是为了推动我们全面进行的这种深度简化，因为我们还履行了我们对剥离产品长尾的承诺，无论是在 Gen Med 和消费者健康。所以我们真的在多个方面执行转型。

风险提示

研发管线进展阻滞；仿制药侵占市场；新冠肺炎疫情复发

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层
 邮编：100032
 传真：010-57671718
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层
 邮编：200120
 电话：021-38124100
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com